

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	膀胱癌 Bladder cancer				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-K10	N13 翁岱鈺	99 年 01 月 20 日	113 年 12 月 17 日	114 年 10 月 02 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
	第 4.0 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解膀胱癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

膀胱癌泛指各種源自膀胱的惡性腫瘤，以尿路上皮細胞癌(urothelial cell carcinoma)最多，占 90-95%。就部位而言，84%都長在膀胱的側面及後壁處，其中 40%長在膀胱三角區，膀胱癌好發於 50~70 歲的年齡群，與環境、抽煙、從事化學物質有關。根據衛生福利部公布 109 年膀胱癌發生率男性及女性排名在 10 名以外，但膀胱癌為高復發風險的疾病。

（二）症狀

約有 75%膀胱癌病人最先顯示症狀是肉眼可見的間歇性無痛性血尿；第二常見的是膀胱的刺激反應，如頻尿、尿急和排尿困難；之後的症狀都是以侵入到膀胱所引起的症狀。最需注意的是泌尿道感染（尤其是老年人），嚴重的病人會有直腸阻塞、骨盆區域疼痛或下肢水腫（淋巴和靜脈阻塞之故）。

（三）常見檢查

1. 尿液細胞學檢查：尿液細胞學檢查在顯微鏡下觀察尿液中所含的膀胱壁脫落的細胞是否有癌細胞存在。

主題名稱	膀胱癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K10	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/7

- 2.膀胱鏡：經由尿道放入內視鏡可看到膀胱的異常變化，並行組織切片檢查。
- 3.靜脈注射腎盂攝影術(IVP)：將顯影劑由靜脈注入體內，再利用 X 光來檢查腎臟、輸尿管及膀胱。
- 4.電腦斷層及核磁共振：檢查輸尿管、淋巴結及骨盆腔內器官的異常。
- 5.超音波檢查。

(四) 常見治療

膀胱癌的治療與疾病侵犯程度的不同而有差異，一般的膀胱癌分類是從零期到第四期等五種：

- 1.零期：腫瘤侷限於黏膜層。治療以經尿道內視鏡腫瘤切除手術或電燒即可。
- 2.第一期：腫瘤侵犯已超過黏膜層，但未達肌肉層，治療的方法亦是經尿道內視鏡腫瘤切除手術或電燒；雷射燒灼也是可行的方法。在這二期的病人須作定期的膀胱鏡追蹤檢查，而且往往需要膀胱內化學藥物灌注。大約有 30% 的病人不再復發，但其餘的仍有復發的可能，而且其中約 10% 會患有更深層的癌細胞侵犯。故在膀胱鏡追蹤檢查方面，一般建議是每三個月做一次膀胱鏡檢查，兩年後改成每半年檢查一次，再兩年後改為每年檢查一次。
- 3.第二期：腫瘤侵犯膀胱肌肉層，經尿道內視鏡腫瘤切除術後，如果腫瘤能完全切除而且癌細胞分化良好，則可採用第一期追蹤治療。如果切除不完全或癌細胞分化不良，則採取第三期的治療方法。
- 4.第三期：腫瘤侵犯已進入深部肌肉層或已超出膀胱壁。內視鏡手術治療已無法完全切除，此時就必須採取較廣泛性的治療。方法包括放射線治療、化學藥物治療、手術治療或者合併使用的各種方法。手術治療則以膀胱切除，然後再以一段大腸或小腸來取代膀胱。
- 5.第四期：腫瘤侵犯已至膀胱以後的器官或有淋巴腺轉移。此時則以放射線治療或化學藥物治療。

(五) 護理問題

- 1.焦慮感受／與癌症的診斷及術後不確定的預後有關。

主題名稱	膀胱癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K10	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/7

2. 身體心像不一致／與身體結構改變有關。
3. 易感染／與細菌侵入造瘻口、輸尿管迴腸逆流有關。

(六) 護理措施

1. 焦慮感受／與癌症的診斷及術後不確定的預後有關
 - (1) 持續評估病人焦慮症狀如：失眠及易怒等程度。
 - (2) 減少刺激，保持寧靜及安全的環境。
 - (3) 鼓勵病人表達所擔心的事及感受。
 - (4) 鼓勵病人及家屬了解疾病及手術的一切狀況。
 - (5) 協助病人及家屬對於疾病與手術採取一致性的態度，使家屬能成為病人的主要支持者。
 - (6) 鼓勵病人討論其對疾病焦慮的感受。
 - (7) 與病人共同制定其護理計畫。
 - (8) 評估病人自我照顧及家屬的照顧能力，必要時予以轉介。
2. 身體心像不一致／與身體結構改變有關
 - (1) 鼓勵病人表達對身體部位改變的看法。
 - (2) 接受病人所表達的感受並表示接受。
 - (3) 尊重病人隱私，情緒退縮與否認。
 - (4) 鼓勵病人用言語表達對身體心像改變的感受及意義。
3. 易感染／與細菌侵入造瘻口、輸尿管迴腸逆流有關
 - (1) 指導病人注意造瘻口，若由原來粉紅色且潮濕，變成暗紅色或發紺，表示血流受阻，宜盡速報告醫師。
 - (2) 注意尿液排出量，每小時小於 30cc 則需注意有無發炎、鹼性尿液易引起造瘻口周圍結痂，或是過胖引起狹窄造成尿液滯留。
 - (3) 確認造口袋及透氣膜環之密合良好，當造口袋之尿量達一半時應排空造口袋，以避免因活動及造口袋內之內容物過重，導致造口袋周圍之人工皮脫落，造成排出物滲漏而刺激皮膚。

主題名稱	膀胱癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K10	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/7

(4) 指導病人如有以下症狀，如腹脹、觸痛、發燒、尿液排出減少，可能有尿液內漏引起腹膜炎，應盡快告知醫師做手術修補。

(5) 隨時觀察造瘻口及周圍有無發生造瘻口脫垂及組織沾粘。

(七) 衛教指導

1. 手術前醫師會與病人及家屬討論手術過程，病人必須準備皮膚、灌腸、禁食等，經由麻醉科醫師評估後決定採全身麻醉或半身，如採半身麻醉，術後須平躺休息 6-8 小時，傷口出血，會有血尿，導尿管須放三天左右，所以須大量喝水 2500cc 以上，拔除尿管後二～三天會頻尿、尿失禁、解尿有刺痛感，必須多飲水、勿憋尿、勿劇烈運動，術後一個月才可恢復性生活。
2. 接受重建手術之病人需衛教病人及家屬每天攝取 2500cc 以上的水份、穿著較寬鬆的衣物，並注意人工造口皮膚的照護，例如皮膚是否發紅，可能是因滲漏或更換集尿袋太頻繁所致，一般五至七天更換一次即可，此時可使用造口粘貼粉，並在集尿袋敷上造口皮膚保護物。集尿袋則使用肥皂及微溫的清水洗乾淨。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 台灣癌症基金會(2022，9月)．膀胱癌專區。

<https://www.canceraway.org.tw/rinfo.php?id=9B3B7F46-B5BC-442E-A8BE-0176B54>

主題名稱	膀胱癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K10	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/7

4C6E4

- (二) 李和惠、黃鈺雯、林麗秋(2021)・內外科護理學・於胡月娟總校閱，泌尿系統疾病病人之護理（六版，87-95頁）・華杏。
- (三) 施文萍、黃昭淵、王茹宜(2020)・膀胱根除術於膀胱癌病人性功能之探討・台大護理雜誌，16(1)，5-13。https://doi.org/10.6740/NTUHJN.202001_16(1).0002
- (四) 黃盈芳、郭于綾、陳淑卿（2023）。膀胱癌病人接受治療導致下泌尿道症狀臨床評估及護理處置。長庚護理，34(3)，27-35。https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6386/CGN.202309_34(3).0003
- (五) 魏倩雯、蔡秀鸞、梁淑媛、李思瑩、童恒新(2019)・膀胱癌存活者之健康促進生活型態及其相關因素探討・台灣專科護理師學刊，6(2)，24-36。
https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=P20150413001-201912-202002140008-202002140008-24-36.
- (六) 衛生福利部（2022，12月29日）・公布109年國人癌症登記資料分析結果・衛生福利部新聞稿。https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4576&pid=16436
- (七) Dobruch, J., & Oszczudłowski, M. (2021). Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina (Kaunas, Lithuania), 57(8), 749.
https://doi.org/10.3390/medicina57080749

七、附件

(略)

主題名稱	膀胱癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K10	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定。	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	檢視全文並修正症狀、常見治療及參考資料。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	修改說明定義及衛教指導部份。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	說明常見治療部份新增：內視鏡腫瘤切除手術。	103 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
104.08.31.	3.3	將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 增修第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.5	新增第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.6	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。

主題名稱	膀胱癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K10	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
108.04.11	3.7	1. 第三項第一目新增定義內容。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 新增第六項第一、六目。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過； 108 年 05 月 15 日護理長會議通過； 108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.8	1. 第三項第一、二目說明內容修訂。 2. 第三項第五、六目護理問題修訂。 3. 第六項將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過； 111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.9	1. 第三項第一目說明內容修訂。 2. 第六項將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過； 112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	4.0	第六項將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過； 113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	